**Poder Judiciário**
**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**
**4ª Vara Cível da Comarca de Canoas**

Rua Lenine Nequete, 60 - Bairro: Centro - CEP: 92310205 - Fone: (51)3098-5389 - Email: frcanoas4vciv@tjrs.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5048025-07.2022.8.21.0008/RS**

**AUTOR**: PRISCILA ROBERTA MOREIRA OLIVEIRA

**RÉU**: CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA

# SENTENÇA

Vistos.

**PRISCILA ROBERTA MOREIRA OLIVEIRA** ajuizou "*ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência*" contra **CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA**, **UNIÃO FEDERAL** e **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, todos qualificados.

Narrou, em resumo, que é beneficiária de plano operado pela requerida Centro Clinico, e que possui diagnóstico de Doença de Crohn (CID10: K50.0). Discorreu sobre os efeitos da doença no corpo e na saúde. Disse que precisa fazer uso do imunobiológico Stelara (Ustequinumabe) 260 mg – sendo duas caixas de 130 mg cada ao mês, além de uma caixa de 90 mg a cada 8 semanas (2 meses), como dose de reforço, porém o fornecimento foi negado pelo requerido. Pontuou ser abusiva a negativa de cobertura e formulou pedido de tutela provisória de urgência, a fim de compelir os réus a fornecer o tratamento. Ao fim, pleiteou a procedência da ação, para compelir o réu Centro Clínico ao fornecimento do medicamento e, em caso de impossibilidade deste, fossem os medicamentos custeados pela União Federal ou pelo Estado do Rio Grande do Sul. Juntou documentos (Evento 1).

Após definição da competência e exclusão da União do polo passivo, foi deferida a gratuidade de Justiça à autora e o pedido de tutela de urgência (Evento 33).

Citado, o réu Centro Clínico apresentou contestação. Preliminarmente, impugnou o valor da causa exposto na petição inicial. No mérito, falou sobre não ser de obrigatoriedade do plano o fornecimento do fármaco requerido, tampouco de reembolsá-lo. Sustentou que, de acordo com as determinações da própria ANS, notadamente a DUT – Diretrizes de Utilização, não há qualquer dever legal da ré de fornecer a cobertura para o tratamento solicitado. Discorreu sobre a legislação aplicável e a matéria de direito que entende amparar a sua defesa. Requereu, ao final, a improcedência da ação. Acostou documentos (Evento 43).

Determinada a exclusão do Estado do polo passivo da ação (Evento 47).

Durante a instrução, foram juntados documentos (Eventos 73, 77 e 90).

Intimadas as partes, o réu silenciou e a autora pediu o julgamento do feito (Eventos 95 e 99).

Vieram os autos conclusos para sentença.

**É o relatório.**

**Decido.**

O feito tramitou regularmente, não havendo quaisquer nulidades a serem declaradas.

***Da impugnação ao valor da causa***

Tenho por afastar a impugnação arguida pela parte ré, uma vez que o valor atribuido à causa se justifica pelo custo do medicamento (evento 1, OUT18). É dizer, sendo o fármaco de manutenção contínua e indeterminada, a autora considerou a soma do tratamento por um período de 12 meses, o que se confirma com o que dipõe o artigo 292, § 2º, do CPC:

> *Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:*
> *(...)*
> *§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações.*

Superada a prefacial, passo ao exame do mérito.

***Do mérito***

A ação proposta visa a disponibilização da medicação Ustequinumabe (nome comercial Stelara) como forma de tratamento da autora, na condição de portadora da doença de Crohn (CID10: K50.0).

O estado clínico da demandante é incontroverso e está demonstrado através dos documentos juntados com a inicial e dos laudos acostados aos evento 1, LAUDO13, evento 1, LAUDO14, evento 1, LAUDO15 e evento 1, LAUDO16.

Da mesma forma, é incontroversa a relação com a ré, além de demonstrada pelos documentos acostados ao evento 1, OUT10. Igualmente, a negativa da requerida apresentada no mesmo documento evidencia a existência do vínculo vigente.

Ora, como já referido em sede liminar, o pleito submete-se à novidade legislativa prevista pela Lei 14.454/22, considerando que o indeferimento ocorreu ao suposto argumento de que a medicação não está prevista no rol da ANS ou, então, não atende às chamadas Diretrizes de Utilização.

Assim dispõem a nova legislação:

*Art. 2º A Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:*

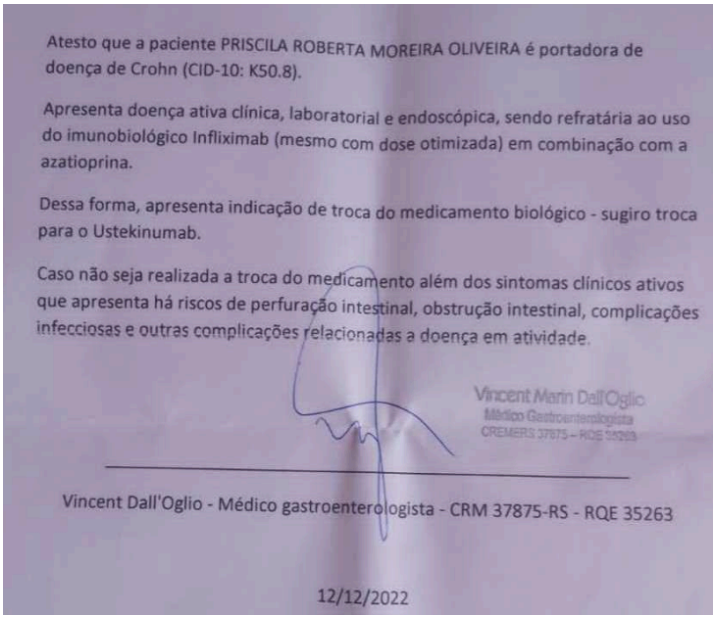
*"Art. 10. .....*

*§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que* ***não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo****, a* ***cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde****, desde que:*

*I - **exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico**; ou*

*II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)*

À vista disso, verifico que o laudo expedido no evento 1, DOC17, assim atesta:



Atesto que a paciente PRISCILA ROBERTA MOREIRA OLIVEIRA é portadora de doença de Crohn (CID-10: K50.8).

Apresenta doença ativa clínica, laboratorial e endoscópica, sendo refratária ao uso do imunobiológico Infliximab (mesmo com dose otimizada) em combinação com a azatioprina.

Dessa forma, apresenta indicação de troca do medicamento biológico - sugiro troca para o Ustekinumab.

Caso não seja realizada a troca do medicamento além dos sintomas clínicos ativos que apresenta há riscos de perfuração intestinal, obstrução intestinal, complicações infecciosas e outras complicações relacionadas a doença em atividade.

Vincent Marin Dall'Oglio
Médico Gastroenterologista
CREMERS 37875 – RQE 35263

Vincent Dall'Oglio - Médico gastroenterologista - CRM 37875-RS - RQE 35263

12/12/2022

Ou seja, o médico que assiste a autora, através do laudo elaborado e acima citado, atesta a importância e a necessidade do tratamento indicado, além de citar os riscos em caso de não utilização do fármaco.

No mais, a parte autora colaciona no corpo da petição inicial as evidências para embasamento da eficácia das terapias propostas, divulgadas inclusive no próprio site da ANVISA[1], e evidenciadas pelas Notas Técnicas que aportaram aos autos (evento 77, NOTATEC1 e evento 77, NOTATEC2), cujas conclusões merecem a citação:

**Conclusão**

**Tecnologia:** USTEQUINUMABE

**Conclusão Justificada:** Favorável

*Página 4 de 6*

**Conclusão:** Há evidência científica de boa qualidade indicando que o tratamento com ustequinumabe pode resultar em benefício clínico em pacientes com doença de Crohn que apresentaram falha de resposta com uso de agentes biológicos anti-TNF, como o caso em tela.
Além disso, análises econômicas em outros países mostraram que a estratégia de utilizar o ustequinumabe é custo-efetiva. Por fim, o paciente parece ter esgotado as opções terapêuticas disponíveis no SUS.

**Há evidências científicas?** Sim

**Conclusão**

**Tecnologia:** USTEQUINUMABE

**Conclusão Justificada:** Favorável

**Conclusão:** CONSIDERANDO o diagnóstico de DOENÇA DE CROHN GRAVE, conforme dados médicos acostados ao processo.

CONSIDERANDO que há evidência em literatura médico-científica que a terapia com USTEQUINUMABE traz benefícios a pacientes portadores da doença acima, refratários à terapia com as drogas disponíveis no SUS.



CONSIDERANDO a disponibilidade da droga no SUS, embora com indicação diversa.

CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS técnicos para sustentar a indicação da USTEQUINUMABE no caso em análise na presente solicitação.

**Há evidências científicas?** Sim

Destarte, entendo como plenamente atendido o requisito contido no inciso I do §13º do art. 10, da Lei nº 9.656, com as alterações realizadas pela Lei 14.454/22.

A corroborar a mitigação do rol em casos como o presente, cito jurisprudência recente do TJ/RS e que refere, inclusive, a existência da Nota Técnica nº 28119, de 26/05/2021, prevendo que o medicamento *Ustequinumabe* é recomendado para tratar Retocolite Ulcerativa, uma das patologias que acometem a parte autora:

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO RELACIONADO À DOENÇA DIVERSA. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. ART. 10, §13 DA LEI Nº 9.656/98. REQUISITOS PRESENTES. - A controvérsia objeto da lide - dever (ou não) de cobertura, pelo plano de saúde, de medicamento ou procedimento indicado pelo médico assistente - encontrava amplo espaço para divergência jurisprudencial em todos os âmbitos do Poder Judiciário, o que também refletia nos julgados proferidos pelo STJ. Assim, a Seção competente ao julgamento da matéria (Terceira e Quarta Turmas) do Tribunal da Cidadania, fixou teses sobre a matéria, indicando que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. - Subsequentemente, a Lei dos Planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei nº 9.656/98) sofreu alterações com o advento da Lei nº 14.454 de 21 de setembro de 2022, que acresceu o §13, que preconiza que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico que não estejam previstos no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que (i) exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; o (ii) existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. - No caso dos autos, a parte autora é acometida de Retocolite Ulcerativa Idiopática e, muito embora inexista correlação entre a enfermidade e o fármaco no rol da ANS, é cabível a sua mitigação, pois a plataforma e-NatJus, por meio da Nota Técnica nº 28119, de 26/05/2021, prevê que o medicamento Ustequinumabe é recomendado para tratar Retocolite Ulcerativa, tornando presentes os requisitos do §13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/98. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50002115620188210002, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 07-10-2022)*

Não bastasse, destaco que a enfermidade que afeta a demandante é coberta pelo plano de saúde, pelo que a este não cabe selecionar o tipo de tratamento dispensando ao beneficiário para manejo e controle da doença, quando possuir cobertura de tratamento:

> *"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. É abusiva a cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1353634/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019)*

> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. RECUSA. ABUSIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. DEVER DE COBERTURA. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 469 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1374307/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)*

Diante disso, faz jus a autora ao fornecimento do medicamento Ustequinumabe (Stelara), conforme a prescrição do médico assistente.

Nesse quadro, a procedência da ação é de rigor.

**DIANTE DO EXPOSTO**, **JULGO PROCEDENTE** a ação ajuizada por **PRISCILA ROBERTA MOREIRA OLIVEIRA** em face de **CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA**, e confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela provisória para o fim de **DETERMINR** à ré que forneça à autora o tratamento objeto do feito - fármaco STELARA (Ustequinumabe) -, na periodicidade e na forma da fundamentação, enquanto comprovada a necessidade por laudos médicos atualizados.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do procurador da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando os ditames do art. 85, § 2º do CPC.

Agendei as intimações.

Publicação e registros eletrônicos.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANE DI DOMENICO HAAS, Juíza de Direito**, em 10/9/2024, às 17:24:9, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10066908943v17** e o código CRC **4fc5497e**.

1. https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/stelara-ustequinumabe-nova-indicacao ↩